

Câncer do colo · rastreio e condutas

Quase todo câncer cervical liga-se ao HPV. Rastreio com citologia/HPV detecta pré-malignos; vacina previne. Lesão invasiva muda para estadiamento e tratamento oncológico.

Rastreio (conceito MS)

Dica - Rastreio (conceito MS)

Citologia de 25–64 anos, após dois anuais normais !' a cada 3 anos. Teste de HPV entra em protocolos atualizados — siga a banca/MS vigente.

Décadas de janela: rastreio intercepta NIC antes da invasão.



Condutas high-yield

- ASC-US/LSIL: repetir ou tipagem HPV conforme fluxo etário
- HSIL/ASC-H/AGC: colposcopia; tratar NIC 2/3 (excisão)
- Invasivo inicial: cirurgia (conização/histerectomia radical conforme estágio)
- Localmente avançado: radio + quimio (cisplatina) clássica

Sinais de invasão

Achado | Nota

Sangramento de contato | Pós-coito clássico

Corrimento fétido | Tumor avançado

Dor pélvica / linfedema | Doença avançada

Citologia com células invasivas | Referência oncológica

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Gestante com citologia alterada: colposcopia é segura; evita-se excisão desnecessária no 1ºT sem invasão. Vacina HPV não trata infecção já estabelecida — previne.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Colo uterino: Bethesda interpreta a citologia; rastreamento por faixas etárias (citologia/HPV) é pergunta fixa.

Bethesda - ideia

Resultados citológicos clássicos

NILM - negativo	rotina
ASC-US	HPV/rep
LSIL (NIC1)	seguir
ASC-H	colpo
HSIL (NIC2/3)	colpo
AGC / cancer	urgente

ASC-US -> HPV / repetir | HSIL/AGC -> colposcopia

Faixas etárias clássicas de rastreamento do câncer de colo.

Rastreamento colo (faixas)

Ideia MS / protocolos BR



Rastreamento — faixas (ideia MS)

Faixa | Conduta clássica

Início | 25 anos (sexualmente ativas) — citologia

Intervalo | Após 2 anuais consecutivos normais !' a cada 3 anos

Término | Após 64 anos com históricos adequados negativos

HPV / coteste | Protocolos novos podem incorporar HPV; cite o do enunciado

Conduta citológica

Dica - Conduta citológica

ASC-US: HPV ou repetir citologia. ASC-H/HSIL/AGC: colposcopia. Nunca tratar só pelo Pap sem correlação.

Vacina HPV (contexto)

- Prevenção primária — não substitui rastreamento
- Faixas e doses conforme calendário vigente no enunciado